

TEMA 15 INFECCIONES NOSOCOMIALES: DEFINICIÓN, CADENA EPIDEMIOLÓGICA, BARRERAS HIGIENICAS. PROCEDIMIENTO DEL USO CORRECTO DE GUANTES EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES. ANTE ENFERMEDADES INFECCIOSAS: DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y TIPOS DE AISLAMIENTO.USO CORRECTO DE EPIS. EQUIPAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE AISLAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES.

Conceptos básicos

- Infección: entrada y multiplicación de microorganismos patógenos en el organismo, con o sin síntomas.
- Infección nosocomial (IRAS): adquirida durante la asistencia sanitaria, no presente ni en incubación al ingreso (suele considerarse a partir de las 48 h).
- Infección autógena/endógena: producida por la propia flora del paciente cuando se alteran las defensas o se rompe la barrera natural (cirugía, sondas, heridas, antibióticos...).
- Tipos de microorganismos: bacterias, virus, hongos, parásitos (protozoos y helmintos).
- Propiedades clave del agente: infectividad (capacidad de entrar y multiplicarse), patogenicidad (capacidad de producir enfermedad), virulencia (gravedad), contagiosidad (facilidad de transmisión).
- Reservorio: lugar donde vive y se mantiene el agente (humano, animal, suelo/agua/fómites).
- Huésped susceptible: persona con defensas disminuidas o expuesta al riesgo.

Cadena epidemiológica y formas de presentación

- Cadena epidemiológica: agente → reservorio → puerta de salida → vía/mecanismo de transmisión → puerta de entrada → huésped susceptible.
- Puertas de salida/entrada más preguntadas: respiratoria, digestiva, genitourinaria, cutánea, sanguínea.
- Mecanismos de transmisión:
 - Directa: contacto físico, sexual, gotas a corta distancia, transmisión vertical (intraparto, transplacentaria).
 - Indirecta: aire (aerosoles), agua y alimentos, fómites, suelo, vectores (mosquitos, garrapatas, etc.).
- Formas de presentación en la población: caso esporádico, endemia (presencia constante), epidemia (aumento por encima de lo esperado), pandemia (afecta a varios países/continentes).

Historia natural de la enfermedad y prevención

- Fases básicas: periodo de incubación (sin síntomas), fase prodrómica (síntomas generales), fase clínica (síntomas típicos), resolución con curación, secuelas o muerte.
- Niveles de prevención:
 - Primaria: antes de que aparezca la enfermedad (vacunas, educación, control ambiental, higiene).
 - Secundaria: detección precoz y tratamiento temprano (cribados, profilaxis postexposición).
 - Terciaria: evitar secuelas y discapacidad (rehabilitación, control de complicaciones).

Infecciones nosocomiales: puntos clave

- Suponen un problema importante de morbilidad y de costes.
- Más frecuentes: infecciones respiratorias, de sitio quirúrgico, urinarias, bacteriemias y gastrointestinales.
- Factores de riesgo principales: edad avanzada, inmunodepresión, enfermedades crónicas, cirugías, sondaje

vesical, catéteres intravasculares, ventilación mecánica, estancias prolongadas en UCI.

- Microorganismos típicos: bacilos gramnegativos (muy frecuentes), *Staphylococcus aureus* y *S. epidermidis*, *Enterococcus*, hongos tipo *Candida*, virus (herpes, varicela-zóster, hepatitis...).
- Estudio EPINE: alrededor de un 8 % de los pacientes hospitalizados presenta al menos una IRAS; gran parte son prevenibles con medidas adecuadas.

Barreras higiénicas y EPIs

- Barreras físicas personales: lavado de manos, guantes, mascarilla, bata, gorro, calzas, gafas/pantalla.
- Barreras estructurales: habitaciones individuales, presión positiva o negativa, filtros en ventilación y respiradores.
- Barreras naturales del organismo: piel intacta, mucosas, secreciones (saliva, moco), cilios respiratorios, flora normal.
- EPIs: su correcta colocación y retirada es clave; orden típico de colocación: lavado de manos → calzas → gorro → mascarilla → gafas → bata → guantes. Lo primero que se retira al salir son los guantes.

Lavado de manos y uso de guantes

- Es la medida más eficaz y barata para prevenir infecciones.
- Tipos:
 - Higiénico: agua y jabón, antes y después del contacto con el paciente.
 - Antiséptico: con jabón antiséptico, antes de técnicas de mayor riesgo.
 - Quirúrgico: prolongado, con jabón antiséptico, antes de cirugía.
- 5 momentos OMS: antes de tocar al paciente; antes de tarea limpia/aséptica; después de exposición a fluidos; después de tocar al paciente; después de tocar su entorno.

- Guantes: no sustituyen al lavado de manos, son de un solo uso y deben cambiarse entre pacientes y entre zonas sucia/limpia en el mismo paciente.

Aislamientos y desinfección

- Objetivo del aislamiento: cortar la transmisión protegiendo al paciente, al personal y a otros enfermos.
- Tipos clásicos: respiratorio, estricto, cutáneo/heridas, entérico, protector o inverso (inmunodeprimidos).
- Clasificación moderna:
 - Precauciones estándar: para todos los pacientes (higiene de manos, uso de barreras cuando haya riesgo de contacto con fluidos).
 - Precauciones según vía: aérea (mascarilla FFP2/FFP3, puerta cerrada), por gotas (mascarilla quirúrgica a <1 m), por contacto (bata y guantes).
- Desinfección en aislamiento: limpieza continua de habitación y material durante la estancia y desinfección final al alta o traslado (ropa y utensilios como material contaminado).

Ideas clave para test

- Definición de infección nosocomial y tiempo de aparición.
- Elementos de la cadena epidemiológica y vías de transmisión.
- Diferencia entre prevención primaria, secundaria y terciaria.
- Tipos de infecciones nosocomiales más frecuentes y sus principales factores de riesgo (sondaje, catéteres, ventilación, cirugía).
- Orden correcto de colocación/retirada de EPIs.
- Cinco momentos del lavado de manos según OMS.
- Diferencia entre precauciones estándar y precauciones por vía aérea/gotas/contacto.

ACADEMIA LORMAN L.M.